NEURODIVERGENCIA: CUÁNTAS PERSONAS SOMOS Y QUÉ FALTA POR CONOCER

Versión ampliada del informe de población neurodivergente · España, Europa y panorama internacional · Actualización 7 de octubre de 2026

QUÉ AÑADE ESTA ACTUALIZACIÓN

Mantiene las cifras y fuentes del informe anterior y añade una revisión más amplia sobre **qué perfiles, países y edades están realmente representados en la investigación**, infradiagnóstico, coexistencia entre neurodivergencias, desigualdad geográfica y grupos que siguen fuera de la evidencia.

100	18,3 %	22,6 %	38,5 %
trabajos seleccionados en la nueva síntesis	escolares con ≥1 NDD en estudio español	coexistencia de NDD en estudio de Kenia	TDAH actual estimado en autismo en metaanálisis

MENSAJE CENTRAL

Sí existen buenos datos para algunos perfiles y países, pero **todavía no existe un mapa completo y comparable de toda la población neurodivergente mundial**. Las cifras dependen de quién es evaluado, con qué criterios, a qué edad y dentro de qué sistema sanitario o educativo.

1. QUÉ CIFRAS TENEMOS PARA ALGUNOS PERFILES

Perfil	Estimación / hallazgo	Qué significa
Autismo	≈61,8 millones mundialmente; rango 52,1-72,7 M	GBD 2021, todas las edades; estimación publicada en 2025
TDAH adulto con inicio infantil	≈139,84 M; 2,58 %	Revisión internacional; estimación para 2020
Síntomas de TDAH en adultos	≈366,33 M; 6,76 %	Definición más amplia; no equivale a diagnóstico confirmado
Dislexia	≈7,10 % de escolares de primaria	Metaanálisis internacional; población escolar
DCD / dispraxia	≈5 % de niños/as	Revisión internacional; varía según método
Discapacidad intelectual	≈1,04 %	Revisión internacional histórica; referencia antigua
TDL	7,58 % (5,33-10,66 %)	Estudio poblacional escolar en Inglaterra
Tourette en adultos	≈0,05 % / 118 por millón	Revisiones con pocos estudios y métodos distintos

NO SE PUEDEN SUMAR ESTOS PORCENTAJES

Una misma persona puede ser autista y tener TDAH, dislexia, DCD u otros perfiles. Sumar prevalencias como si fueran grupos independientes puede contar a una persona varias veces.

2. EL NUEVO HALLAZGO CLAVE: LA INFORMACIÓN POBLACIONAL ES DESIGUAL

La nueva revisión confirma que el problema no es simplemente que «falten cifras». La investigación está distribuida de forma muy desigual por diagnóstico, edad, país y nivel de apoyo.

Perfil	Población más estudiada	Situación de la evidencia
Autismo	Niñez y adolescencia	La condición más estudiada en varias revisiones de África y América Latina
TDAH	Niñez escolar y adolescencia	Más datos poblacionales, pero persisten sesgos de sexo/género y diagnóstico
Dislexia / SLD	Estudiantes y universitarios	Mucho estudio educativo; menos epidemiología de población general
Discapacidad intelectual	Usuarios de servicios / muestras sociales	Menor cobertura y muestras frecuentemente pequeñas
TDL	Niñez y adultez joven	Evidencia creciente, todavía heterogénea
DCD / dispraxia	Niñez escolar	Infrarreconocida pese a prevalencia no trivial
Tourette / tics	Juventud clínica	Base poblacional mucho menor que autismo o TDAH

QUÉ SIGNIFICA

No encontrar una buena cifra para un perfil no significa que sea raro ni poco importante. Puede significar que **no se ha buscado con suficiente amplitud, que se estudia solo en determinados grupos o que no existen sistemas adecuados para identificarlo**.

3. PAÍSES: LA MISMA REALIDAD SE VE DE FORMA DISTINTA SEGÚN CÓMO SE MIDA

País / región	Población / diseño	Hallazgo destacado
España	6.834 escolares; múltiples NDD	18,3 % tuvo al menos un trastorno del neurodesarrollo; solo una minoría estaba previamente diagnosticada
Chile	3.056.306 alumnos; autismo	Prevalencia proyectada 1,31 %, superior a la detectada solo por registros escolares
Kenia	11.223 niños cribados	Prevalencia ajustada de NDD 9,1 %; coexistencia 22,6 %
Sudáfrica	≈1 millón de escolares	Fuerte subidentificación en estudios escolares
América Latina	Encuestas y estudios de varios países	Barreras de acceso y demora diagnóstica; evidencia concentrada en pocos países
África subsahariana	Revisión de 53 publicaciones	La revisión histórica no encontró epidemiología robusta de autismo hasta 2015

DESIGUALDAD GEOGRÁFICA

Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países de altos ingresos aportan una parte desproporcionada de la literatura. África, América Latina y países de ingresos bajos o medios están mucho menos representados. Esto limita cualquier intento de estimar una «prevalencia global» uniforme.

4. ESPAÑA: QUÉ SABEMOS Y QUÉ SIGUE FALTANDO

AUTISMO

Autismo España utiliza una estimación de alrededor de **500.000 personas autistas**, basada en una referencia aproximada del 1 % de la población. Es una estimación asociativa, no un censo nacional completo.

ESTUDIO ESCOLAR MULTIPERFIL

El estudio de Bosch et al. con **6.834 escolares** aporta una visión especialmente útil porque no estudia una sola condición: encontró que **18,3 %** presentaba al menos un trastorno del neurodesarrollo, con un importante volumen de casos no identificados previamente.

LO QUE TODAVÍA NO TENEMOS

No se ha localizado una cifra nacional que reúna **todos los perfiles, todas las edades, personas diagnosticadas, no diagnosticadas, sospechas y coexistencias**. Por eso intervalos divulgativos como «10-20 % de la población es neurodivergente» no deben presentarse como un censo español.

Para FAND, una prioridad razonable es separar siempre: diagnóstico confirmado · valoración pendiente · sospecha/autorreconocimiento · necesidades de apoyo, sin asumir que estas categorías son equivalentes.

5. INFRADIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO TARDÍO

435.700-1.197.300

personas autistas posiblemente no identificadas en Inglaterra (2018)

294.792

solicitudes de valoración de autismo abiertas en NHS England, junio 2026

55,9 %

adultos de EE. UU. con TDAH declarado que dijeron haber sido diagnosticados en adultez

3,5-7,9 %

estimación de diagnosticados entre autistas ≥50 años en modelo inglés

CUIDADO CON LAS CATEGORÍAS

Una lista de espera no es un diagnóstico; una sospecha no es un diagnóstico; y una estimación estadística de infradiagnóstico no identifica individualmente a las personas. Son indicadores diferentes que sirven para detectar posibles huecos del sistema.

6. COEXISTENCIA: UNA PERSONA PUEDE TENER VARIOS PERFILES

La nueva información refuerza un problema metodológico importante: muchos estudios y sistemas administrativos siguen contando diagnósticos por separado, aunque la coexistencia es frecuente.

38,5 %	40,2 %	22,6 %	>8×
TDAH coexistente actual estimado en autismo	TDAH a lo largo de la vida estimado en autismo	niños con NDD y coexistencia en estudio de Kenia	otros problemas del neurodesarrollo en dislexia vs lectores típicos

POR QUÉ IMPORTA

Si contamos cada diagnóstico como si correspondiera a una persona distinta, **inflamos el total**. Si solo estudiamos un diagnóstico principal, **ocultamos necesidades combinadas**. Un mapa poblacional útil debe permitir estudiar perfiles múltiples sin duplicar personas.

7. QUIÉNES SIGUEN QUEDANDO FUERA DE LOS ESTUDIOS

Grupo poco representado	Problema
Adultos y personas mayores	Gran parte de la epidemiología nace en escuela o infancia; falta seguimiento de toda la vida
Personas no hablantes	Frecuentemente excluidas por instrumentos y diseños que exigen comunicación verbal/escrita
Personas con discapacidad intelectual asociada	A veces excluidas de estudios de autismo u otros perfiles
Mujeres y niñas	Sesgos diagnósticos y presentaciones menos reconocidas en varios perfiles
Minorías étnicas / raciales	Acceso desigual, muestras poco diversas y retrasos diagnósticos
Personas con menos recursos	Barreras de acceso a valoración y menor representación investigadora
Global Sur	Menos cohortes, registros y epidemiología comparable
Perfiles múltiples	Los estudios suelen organizarse por diagnósticos aislados

LA CELDA MÁS VACÍA

La combinación **adultez + Global Sur + coexistencia** aparece como uno de los mayores vacíos. Precisamente ahí pueden concentrarse personas que nunca fueron identificadas en la infancia y sistemas con menos recursos diagnósticos.

8. PERFILES CON CIFRAS TODAVÍA MUY INCOMPLETAS

Perfil	Qué sabemos	Qué falta
Discalculia	Existen estudios escolares y educativos	Estimaciones comparables entre países y edades
Disgrafía	Revisión de 77 estudios mostró producción limitada y poca diversidad	Definiciones homogéneas y epidemiología poblacional
Disortografía	A menudo agrupada con lectura/escritura	Recuento específico y criterios comparables
DCD / dispraxia	≈5 % infantil en revisión; investigación adulta creciente	Seguimiento adulto y envejecimiento
TDL	7,58 % en estudio escolar inglés; evidencia adulta emergente	Datos de vida adulta y países diversos
Tourette / otros tics	Estimaciones adultas escasas y variables	Datos separados por tipo de tic y edad
Altas capacidades	Identificación depende mucho de criterios educativos	Cifras transparentes y doble/múltiple excepcionalidad
Procesamiento sensorial / otros perfiles	Investigación heterogénea	Definir claramente qué se cuenta y con qué criterios

9. LA TERCERA EDAD TAMBIÉN CUENTA

AUTISMO

Las revisiones recientes muestran un crecimiento de la investigación sobre envejecimiento, pero siguen siendo pocos los estudios longitudinales y las personas mayores de 65 años o con mayores necesidades de apoyo. No existe evidencia de que todas las personas autistas envejezcan de la misma manera.

TDAH

La investigación en mayores continúa siendo escasa. Una revisión encontró estimaciones muy distintas según el método: 2,18 % en evaluaciones de investigación, 0,23 % en diagnósticos clínicos y 0,09 % en datos de tratamiento. La forma de medir cambia radicalmente lo que vemos.

OTROS PERFILES

Dislexia, TDL, DCD/dispraxia, Tourette y otros perfiles tienen todavía menos información sobre envejecimiento, acceso a cuidados, autonomía, vivienda, duelo y cambios cognitivos.

10. POR QUÉ DOS ESTUDIOS PUEDEN DAR CIFRAS DIFERENTES

Factor	Cómo cambia la cifra
Definición diagnóstica	Criterios distintos incluyen o excluyen personas diferentes
Registro vs encuesta	Un registro cuenta identificados; una encuesta puede captar autoinforme
Cribado vs diagnóstico	Un cribado detecta señales, no confirma el diagnóstico
Edad	Una cifra escolar no representa automáticamente a toda la población
Sexo/género	Sesgos de reconocimiento pueden modificar quién llega al diagnóstico
Acceso sanitario/educativo	Menos acceso puede producir menos diagnósticos registrados sin que haya menor prevalencia real
Año de los datos	Un artículo reciente puede analizar datos de muchos años antes
Coexistencia	Contar diagnósticos por separado puede duplicar personas

POR ESO FAND NO DEBE PUBLICAR UNA ÚNICA CIFRA GLOBAL SIN CONTEXTO

Una cifra útil necesita al menos: **perfil, población, edad, país, año, método, definición y fuente**. Sin esos datos, comparar porcentajes puede resultar engañoso.

11. QUÉ PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN SON PRIORITARIAS

Pregunta	Por qué importa
¿Cuál es la prevalencia comparable de perfiles múltiples en países de ingresos bajos y medios?	La coexistencia es frecuente, pero se sigue midiendo cada diagnóstico por separado
¿Qué grupos siguen sistemáticamente infradiagnosticados?	Mujeres, minorías, personas pobres y perfiles complejos aparecen con retrasos repetidos
¿Qué ocurre en la adultez con TDL, DCD, Tourette, dislexia y otros perfiles?	La evidencia se concentra en infancia y escuela
¿Cómo envejecen las personas con distintos perfiles y necesidades de apoyo?	La tercera edad está poco representada
¿Cómo contar sin excluir a personas no hablantes o con discapacidad intelectual?	Muchos diseños tradicionales las dejan fuera
¿Cómo medir necesidades además de diagnósticos?	Dos personas con la misma etiqueta pueden requerir apoyos muy diferentes

PRIORIDAD FAND

Medir mejor, incluir mejor y comparar mejor. La investigación poblacional debería contar personas sin borrar las combinaciones entre perfiles ni las diferencias de apoyo.

12. QUÉ NOS DICEN TODOS LOS ESTUDIOS EN CONJUNTO

1 · HAY MUCHAS PERSONAS QUE TODAVÍA NO VEMOS

Los registros diagnósticos no equivalen a prevalencia real. Infradiagnóstico, listas de espera, acceso desigual y diagnóstico tardío pueden ocultar una parte importante de la población.

2 · AUTISMO Y TDAH NO REPRESENTAN TODA LA NEURODIVERGENCIA

Son los perfiles con mayor visibilidad investigadora. DLD/TDL, DCD, Tourette, disgrafía, discalculia y perfiles combinados tienen mucha menos información.

3 · EL MAPA MUNDIAL ESTÁ SESGADO

Los países de altos ingresos concentran estudios y registros. El Global Sur sigue insuficientemente representado.

4 · LA COEXISTENCIA ES CENTRAL

Una persona puede reunir varios perfiles. Las políticas y estudios que tratan cada diagnóstico como un grupo aislado pueden describir mal la realidad.

5 · FALTAN DATOS PARA PLANIFICAR APOYOS DURANTE TODA LA VIDA

La investigación necesita pasar de contar diagnósticos infantiles a comprender necesidades, apoyos, participación y calidad de vida desde la infancia hasta la vejez.

13. POR QUÉ NECESITAMOS FAND

Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia. Y detrás de los datos que faltan también hay personas: quienes todavía no tienen diagnóstico, quienes no encuentran respuestas, quienes tienen varios perfiles y quienes apenas aparecen en las investigaciones.

ESCUCHAR

Recoger por separado experiencias de personas con diagnóstico, sospecha, valoración pendiente y distintas necesidades de apoyo.

CONECTAR

Acercar personas, familias, asociaciones, profesionales e investigadores para compartir recursos y detectar vacíos.

INVESTIGAR MEJOR

Promover estudios que incluyan perfiles menos visibles, coexistencias, adultos, mayores, diversidad territorial y diferentes necesidades de apoyo.

TRANSFORMAR DATOS EN APOYOS

No queremos quedarnos solo en contar personas. Queremos que el conocimiento contribuya a mejorar apoyos, defender derechos y construir entornos accesibles e inclusivos.

Tu experiencia cuenta. Tu voz hace falta.

14. FUENTES Y NOTA METODOLÓGICA

Esta versión integra las 30 fuentes del informe FAND anterior con la nueva síntesis documental aportada para la actualización. Entre los trabajos que amplían la interpretación destacan estudios y revisiones de Francés (2022), Bosch (2021), Roman-Urrestarazu (2025), Kariuki (2025), Franz (2017), Rong (2021), Brimo (2021), Davies (2024), Clouder (2020), Dubois (2020), Petter (2025), De Roubaix (2024-2025), Adams (2024), De Jesús Garza Guerra (2026), Martin (2024), Glencross (2021) y otros trabajos del corpus.

ALCANCE

La nueva búsqueda descrita en el material complementario recuperó un corpus amplio y seleccionó 100 trabajos para el análisis final. Esta versión de FAND utiliza sus resultados como **ampliación documental**. No debe presentarse como un censo realizado por FAND ni como una revisión sistemática registrada por la asociación.

Las referencias completas del informe original se mantienen como base documental. Antes de utilizar cifras para decisiones clínicas, legales o de política pública debe consultarse la publicación original correspondiente.